

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

ESCALA DE IMPULSIVIDAD DE BARRATT (BIS-11)

Barratt Impulsiveness Scale (Patton, Stanford & Barratt, 1995) · Adaptación Española (Oquendo et al., 2001; Salvo & Castro, 2013)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Escala de Impulsividad de Barratt - Versión 11 (Barratt Impulsiveness Scale, BIS-11)
Sigla / Acrónimo	BIS-11
Autoría original	Ernest S. Barratt, Jim H. Patton & Matthew S. Stanford (Univ. of Texas Medical Branch, 1995)
Adaptación en español	María A. Oquendo et al. (2001, Actas Esp Psiquiatr); Salvo & Castro (2013, Rev Chil Neuro-Psiquiatr)
Constructo evaluado	Impulsividad disposicional o rasgo: predisposición a actuar de forma rápida e imprevista sin reflexionar
Población diana	Adolescentes y adultos en contextos clínicos de TDAH, adicciones, TLP, conducta antisocial y forense
Tiempo de aplicación	5 a 8 minutos (autoadministrado)
Estructura y formato	30 ítems evaluados en escala Likert de 4 puntos (1 = Rara vez/Nunca; 4 = Siempre/Casi siempre)
Condiciones de uso	Dominio público para uso asistencial e investigación académica citando a Patton et al. (1995)

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

La impulsividad es un constructo conductual y neurobiológico complejo definido como una predisposición biológica hacia reacciones rápidas, no planificadas, ante estímulos internos o externos, sin tener en cuenta las consecuencias negativas potenciales para uno mismo o los demás. Se asocia a una hipofunción de la corteza prefrontal ventromedial y orbitofrontal junto con una hiperreactividad del sistema dopaminérgico mesolímbico estriatal.

Ernest Barratt dedicó más de tres décadas a refinar la operacionalización psicométrica de la impulsividad, superando la noción unidimensional simple. La versión BIS-11 estructura la impulsividad en tres dimensiones interrelacionadas: 1) **Impulsividad Cognitiva o Atencional** (dificultad para mantener el foco mental y tomar decisiones ponderadas); 2) **Impulsividad Motora** (actuación precipitada en el calor del momento); y 3) **Impulsividad No Planificada** (desorientación hacia el presente inmediato con incapacidad para prever el futuro).

3. ESTRUCTURA DE SUBESCALAS DE LA ESCALA BIS-11

Subescala	Nº ítems	Rango	Procesos Cognitivo-Conductuales Evaluados
Impulsividad Cognitiva	8 ítems	8 - 32	Inestabilidad atencional, rumiación caótica y falta de paciencia cognitiva (ítems 5, 9, 11, 20, 24, 26, 28, 30)
Impulsividad Motora	11 ítems	11 - 44	Actuación súbita motora, inquietud física e impulsos desinhibidos (ítems 2, 3, 4, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 29)
Falta de Planificación	11 ítems	11 - 44	Falta de previsión de consecuencias a largo plazo e intolerancia a la postergación (ítems 1, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 27)

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS EN POBLACIÓN ESPAÑOLA

Consistencia interna	Excelente consistencia total; alfa de Cronbach $\alpha = 0.84 - 0.88$ en población clínica española (Oquendo et al., 2001) y $\alpha = 0.80$ en población comunitaria.
Estabilidad temporal	Fiabilidad test-retest a 3 meses con CCI = $0.79 - 0.83$, confirmando que evalúa un rasgo conductual relativamente estable.
Validez convergente	Correlación positiva significativa con la Escala UPPS-P ($r = 0.72$), búsqueda de sensaciones de Zuckerman ($r = 0.58$) y conductas autolesivas en TLP ($r = 0.54$).
Validez de criterio	Discrimina nítidamente entre controles sanos vs. pacientes con trastorno bipolar en fase maniaca/mixta, juego patológico y agresores forenses.
Sensibilidad al cambio	Capaz de registrar mejoría tras tratamiento farmacológico con estabilizadores del ánimo, antipsicóticos atípicos o entrenamiento en Terapia Dialéctico-Conductual (DBT).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Escala Likert ordinaria	Cada ítem se califica de 1 a 4: 1 = Rara vez o nunca ; 2 = Ocasionalmente ; 3 = A menudo ; 4 = Siempre o casi siempre .
Inversión obligatoria	Para evitar sesgos de aquiescencia, se deben invertir 14 ítems (asignando 4 = 1; 3 = 2; 2 = 3; 1 = 4): 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 20, 29, 30 (y en versión española estándar también 14, 18, 27 según clave de Oquendo).
Puntuación directa global	Suma aritmética simple de los 30 ítems (tras las inversiones). Rango teórico posible: 30 a 120 puntos .
Puntuación de subescalas	Se obtienen las 3 puntuaciones específicas sumando sus ítems respectivos: Cognitiva (8-32), Motora (11-44) y No Planificada (11-44).

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación Total	Percentil Aprox.	Estrato de Impulsividad	Significación Clínica y Perfil Conductual
30 - 51 puntos	< Pc 20	Impulsividad Extremadamente Baja	Sujeto rígido, hipercontrolado o con exceso de inhibición conductual.
52 - 71 puntos	Pc 20 - Pc 75	Impulsividad Normal / Adaptativa	Rango medio poblacional; flexibilidad adaptativa en la toma de decisiones.
72 - 85 puntos	Pc 80 - Pc 94	Impulsividad Alta Patológica	Dificultades manifiestas de autocontrol; riesgo de conductas de riesgo.
86 - 120 puntos	>= Pc 95	Impulsividad Muy Alta / Extrema	Grave desinhibición psicomotora; alto riesgo de violencia o autolesión.

PUNTOS DE CORTE CRÍTICOS (PATTON & STANFORD):

- **BIS-11 Total ≥ 72 puntos:** Punto de corte diagnóstico que separa a la población normal de pacientes con patología impulsiva severa (abuso de tóxicos, trastorno antisocial o límite de la personalidad).
- **Subescala Motora ≥ 26 puntos:** Predictor crítico de intentos de suicidio impulsivos de alta letalidad médica no premeditados.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE INTERVENCIÓN EN DESCONTROL IMPULSIVO

Paso 1: Aplicación del BIS-11: Obtener puntuación total y de las 3 subescalas.

Paso 2: Si BIS-11 < 72 (Normal): Manejo habitual; verificar si la conducta impulsiva reportada es episódica reactiva a estresores puntuales.

Paso 3: Si BIS-11 ≥ 72 (Impulsividad Alta Patológica):

- **Si predomina Impulsividad Motora (≥ 26):** Implementar técnicas de "pausa forzada" conductual (técnica STOPP), contención ambiental y evitar consumo de sustancias desinhibidoras (alcohol, cocaína).
- **Si predomina Falta de Planificación (≥ 26):** Entrenamiento en resolución de problemas paso a paso y consecuencias proyectadas a medio plazo.
- **Si predomina Impulsividad Cognitiva (≥ 20):** Cribado de TDAH del adulto mediante escalas específicas (ASRS) y entrenamiento en Mindfulness / atención plena.

Paso 4: Abordaje Multimodal: Integrar psicoterapia especializada (DBT o Terapia de Esquemas) y optimización farmacológica con estabilizadores del ánimo.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO EN ADICCIONES Y TLP

Identificación: Varón de 26 años remitido a la Unidad de Conductas Adictivas tras perder su empleo y acumular 12.000 € en apuestas deportivas online y compras compulsivas, con episodios de agresión verbal a sus padres.

Evaluación BIS-11 Inicial: Puntuación Total = **94 / 120** (Impulsividad Muy Alta, Percentil 98).

- Subescala Motora = 36/44 (Severa: "Actúo antes de pensar", "Cambio de idea de golpe").
- Falta de Planificación = 38/44 (Extrema: "Vivo solo el presente", "No me importa el futuro").
- Impulsividad Cognitiva = 20/32 (Inestabilidad atencional).

Diagnóstico Integrado: Trastorno del Control de los Impulsos (Juego Patológico) comórbido con Trastorno Límite de la Personalidad (TLP).

Intervención: Bloqueo voluntario en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGAJ), supervisión económica por terceros, inicio de topiramato 100 mg/día como anti-impulsivo y entrenamiento grupal en DBT en el módulo de tolerancia al malestar.

Reevaluación a los 6 meses: Cero episodios de juego; la puntuación total del BIS-11 disminuyó a **68 / 120** (Rango adaptativo), logrando estabilidad laboral y familiar.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Riesgo de Violencia:

- **Impulsividad Extrema (> 90):** Predictor directo de agresión física hacia otros y conducción temeraria en estados de frustración.
- **Tentativas de Suicidio por Impulso:** El riesgo autolítico no requiere depresión grave si la impulsividad motora es crítica.

Diagnóstico Diferencial:

- **Impulsividad Rasgo vs. Estado Maníaco:** En la manía la impulsividad es episódica y acompañada de menor necesidad de dormir y euforia.
- **TDAH del Adulto:** En el TDAH predomina la impulsividad cognitiva y atencional sobre la búsqueda deliberada de sensaciones de riesgo.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Patton, J. H., Stanford, M. S., & Barratt, E. S. (1995). Factor structure of the Barratt impulsiveness scale. *Journal of Clinical Psychology*, 51(6), 768-774. [https://doi.org/10.1002/1097-4679\(199511\)51:6<3.0.co;2-1](https://doi.org/10.1002/1097-4679(199511)51:6<3.0.co;2-1)
- Oquendo, M. A., Baca-García, E., Graver, R., Morales, M., Montalbán, V., & Mann, J. J. (2001). Spanish adaptation of the Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11). *Actas Españolas de Psiquiatría*, 29(2), 83-90.
- Stanford, M. S., Mathias, C. W., Dougherty, D. M., Lake, S. L., Anderson, N. E., & Patton, J. H. (2009). Fifty years of the Barratt Impulsiveness Scale: An update and review. *Personality and Individual Differences*, 47(5), 385-395.
- Salvo, L., & Castro, A. (2013). Confiabilidad y validez de la escala de impulsividad de Barratt (BIS-11) en adolescentes. *Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría*, 51(4), 245-254.